

성명 유지우

바코드



검진일자 2025.10.17

단체명 *****

부서명 *****

주소 서울 광진구 광장로1다길 24 신축주택

검진센터 KMI강남 검진센터

품격과 가치의 차원이 다른 건강검진 서비스

건강검진결과서

Medical Examination Report



유지우 남자 건강검진 결과표

검사분류	검사항목	사후관리구분
기초검사	신체계측	A 정상
	혈압	B 임상적 의의없음
	안과	E 상담/확인필요
	청력	A 정상
	당뇨	C(3) 경과관찰
	대사증후군	C(12) 경과관찰
순환기	심전도검사(일반)	A 정상
	동맥경화도	C(12) 경과관찰
	경동맥초음파	C(12) 경과관찰
갑상선	지질 및 심혈관 혈액	A 정상
	갑상선 초음파	A 정상
	갑상선 관련 혈액	A 정상
호흡기	흉부 X-ray	B 임상적 의의없음
대장	대장내시경	C(36) 경과관찰
	간, 담도, 췌장 영상	C(12) 경과관찰
간, 담도, 췌장	간,담도,췌장 혈액 & 간염 바이러스	A 정상
신장요로	신장,요관,방광 X-ray	B 임상적 의의없음
	신장 기능 혈액검사	A 정상
	소변 검사	B 임상적 의의없음
혈액	혈액학 & 철대사	B 임상적 의의없음
종양표지자	종양표지자	A 정상
통풍	통풍 및 염증	A 정상
근골격	골대사 및 부갑상선	A 정상
남성의학	전립선 초음파	B 임상적 의의없음
	성매개감염병(남)	A 정상



사후관리구분

사후관리구분은 수검자께서 한눈에 보기
편하도록 만든 것입니다. 더욱 자세한 내용은
다음 장의 종합소견과 홈페이지에서
참고하십시오.

- A: 정상**
검진결과 특이 소견이 없습니다.
- B: 임상적 의의없음**
정상범위를 벗어나, 임상적 의미가
없어 특별한 치료가 필요하지
않습니다.
- C: 경과관찰 (개월수)**
검사결과 추적관찰이 필요합니다.
()개월 후에 예약 후 추적 검사를 통해
경과를 관찰하십시오.
- E: 상담/확인검사 필요**
검진 결과, 치료 여부를 결정하기 위한
전문의 상담 및 정밀 검사가
필요합니다.
- T: 치료상담**
검사상 치료 혹은 상급병원 전원이
필요합니다. 상담에 따라 진료
받으시기 바랍니다.
- F: 불완전 검사**
검진결과 정확한 진단을 내리기
어려웁습니다. 안내에 따라 재검사가
필요할 수 있습니다.
- U: 예측 검진 항목 및 기타**
확진이 아닌 의학적, 임상적 연구
결과를 기반으로 한 예측 검진
항목입니다. 결과에 따라 개인의
잠재적 건강상태를 예측할 수 있으며
확진을 위하여 추가적인 검사가 필요할
수 있습니다. 그 외 기타사항을
안내드립니다.



종합소견

검진결과 의학적으로 의미가 있다고 판단되는 문제점과 이에 대한 참고사항을 다음과 같이 알려드립니다.



E:상담/확인검사 필요합니다.

안과

인공지능 AI 분석(식품의약품안전처 허가)을 바탕으로 한 안저검사 결과 좌안 망막 질환이 의심됩니다. 이는 특별한 치료가 필요 없는 초기 변화일 수도 있지만, 실제로 치료나 관리가 필요한 안과 질환일 수 있습니다. 따라서 정확한 진단과 적절한 관리를 위해 안과 진료를 권유드립니다.



C:경과 관찰이 필요합니다.

당뇨

혈당이 정상보다 다소 높지만 당뇨병 진단기준에 비해서는 낮아 공복시 혈당장애로 분류됩니다. 정상체중 유지 및 지속적인 운동하시고 3개월 후 재검하여 추적관찰 하십시오.

대사증후군

귀하는 위의 항목 중 기준치가 넘는 항목이 두 가지 이하(혈당 장애, 혈압)이므로 대사증후군으로 진단되지는 않습니다만 건강한 생활을 위하여 대사증후군에 대한 내용을 참고하시고 1년 뒤 추적관찰 하시기 바랍니다. ※ 혈압 및 HDL, 중성지방, 공복혈당의 경우 수치가 정상이어도 해당 약물 복용 시 기준치가 넘는 항목으로 분류되오니 참고 바랍니다.

동맥경화도

말초혈관 동맥경화 검사(혈류 속도 측정)에서 동맥경화의 관리범주에 속합니다. 흡연시에는 금연하시고, 일상생활에 주의(체중조절, 저지방식이, 운동)가 필요하며, 정기적인 추적검사 요합니다.

경동맥초음파

경동맥초음파 검사에서 좌측 총경동맥 분기부 내 플라그가 관찰됩니다. 뇌혈관 및 심혈관 질환의 위험인자 이므로 금연 및 당뇨, 체중, 콜레스테롤, 혈압조절이 필요합니다. 정기적 추적검사를 요합니다.

경동맥초음파 검사에서 좌측 내경동맥의 내막이 비후되어 있습니다. 이는 뇌혈관 및 심혈관질환의 위험 인자 이므로 금연 및 당뇨, 체중, 콜레스테롤, 혈압 조절이 필요하며 정기적인 경동맥 초음파 및 고지혈증 검사로 확인 바랍니다.

대장내시경

대장내시경 검사상 (횡행결장)부위에 약 (3)mm 크기의 용종 (1)개 발견되어 용가미를 이용하여 용종절제술 시행하였고 조직검사 결과 (저도이형성 관상선종)으로 진단되었습니다. 이는 양성종양으로 제거된 상태이므로 더 이상의 치료는 필요하지 않으나 경과관찰을 위해 3년 후에 대장내시경 추적검사 필요합니다.

간, 담도, 췌장 영상

복부초음파 검사에서 경도의 지방간이며 간세포 내에 지방이 과다 축적된 상태를 말합니다. 비만, 과음, 운동부족, 당뇨 등이 주원인으로 알려져 있습니다. 지방식을 줄이시고 적당한 운동이 필요합니다.

복부초음파 검사에서 담낭 용종(0.3cm)이 관찰됩니다. 담낭 용종은 담낭의 안쪽 벽에서 안으로 돌출된 다양한 형태의 점막용기를 말하며 1cm미만은 크기가 작아 임상적인 의의가 없으므로 정기적인 추적검사를 통해 모양 및 크기 변화를 관찰하시기 바랍니다.



종합소견

검진결과 의학적으로 의미가 있다고 판단되는 문제점과 이에 대한 참고사항을 다음과 같이 알려드립니다.

B:임상적 의의 없습니다.

혈압	혈압 검사 결과 고혈압 전단계(120/80mmHg~139/89mmHg)입니다. 혈압은 측정 시마다 변하는 것이 정상이며 고혈압 진단을 위해서는 반드시 안정 상태에서 혈압을 측정해야 합니다. 고혈압 전단계는 고혈압으로 진행할 가능성이 높으나 안정 상태에서 혈압이 측정되지 않았을 가능성도 있으므로 규칙적인 운동 및 저염식이 등 생활 습관 관리하시고 주기적으로 편안한 상태에서 혈압을 측정하시기 바랍니다.
흉부 X-ray	흉부촬영상 우상의 비활동성 섬유흔 소견 입니다. 이전 염증등에 의한 변화로 현재 임상적 의의는 없으며 정기적인 검사를 하시기 바랍니다.
간, 담도, 췌장 영상	복부초음파 검사에서 간 우엽 내 석회화가 보입니다. 석회화의 원인은 뚜렷하지 않으나 대부분 간세포나 조직 내에 칼슘이 침착된 것으로 별다른 임상적 의의는 없습니다.
신장,요관,방광 X-ray	KUB(신장, 요관, 방광)촬영에서 골반강내 정맥석이 의심됩니다. 현재 임상적 의의는 없으므로 정기적인 추적 관찰을 요합니다.
소변 검사	소변 검사 결과상 임상 참고치(정상치)에서 다소 벗어나는 소견이 있으나 임상적으로 특별한의의는 없을 것으로 생각됩니다. 정기적인 추적관찰을 권하며, 필요 시 전문의 상담을 요합니다.
혈액학 & 철대사	혈액 검사 결과상 임상 참고치(정상치)에서 다소 벗어난 소견이 있으나 임상적으로 특별한 의의는 없을 것으로 생각됩니다. 건강을 위하여 과로와 스트레스를 피하도록 하십시오.
전립선 초음파	전립선초음파 검사에서 전립선의 일부가 석회화된 소견이 있습니다. 전립선 석회화는 비교적 흔한 소견으로서 임상적으로 문제가 되는 질환은 아니므로 정기적인 추적검사만을 요합니다.

A:정상입니다.

신체계측	허리둘레 정상
안과	안압 검사상 정상입니다.
청력	청력 정상
심전도검사(일반)	정상



종합소견

검진결과 의학적으로 의미가 있다고 판단되는 문제점과 이에 대한 참고사항을 다음과 같이 알려드립니다.

지질 및 심혈관 혈액

LDL-콜레스테롤은 심혈관질환 발생의 주요한 위험인자입니다. 현재 수치가 높지 않으므로 특별한 임상적 의의는 없을 것으로 사료됩니다. 하지만 당뇨병 또는 혈관질환을 앓고 계신 경우에는 더 낮게 조절해야 하므로 필요시 전문의와 상담하십시오.

갑상선 초음파

특이소견없음

갑상선 관련 혈액

정상

간,담도,췌장 혈액 & 간염 바이러스

B형 간염에 대한 항체(HBsAb)가 양성으로 면역이 형성된 상태입니다.

신장 기능 혈액검사

정상

통풍 및 염증

정상

골대사 및 부갑상선

정상

성매개감염병(남)

정상

종양표지자

CEA 검사상 정상범위내에 있습니다. CEA는 대장암 및 폐암에 대한 종양 표지자 검사이나 진단에 보조적 방법으로 선별검사나 확진검사는 아니므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

AFP 검사상 이상이 없습니다. AFP는 간암, 만성간염 등에 대한 종양표지자이나 이는 복부초음파검사 등 다른 진단적 방법에 대한 보조적 검사로서 확진 또는 선별검사는 아닙니다. 그러므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

PSA(전립선 특이항원) 검사상 이상이 없습니다. PSA는 전립선암, 전립선 비대증과 같은 전립선 질환에서 증가하나 진단을 위한 보조적 방법으로 확진 또는 선별 검사는 아닙니다. 따라서 상기질환 의심시 비록 정상범위라해도 반드시 전문의 상담을 요합니다.

판정의 : 정수영 *정수영*

항목별 세부진단결과



홈페이지에서 보다 상세한
건강검진 결과를 확인하세요





기초검사

신체계측

검사명	종전결과(24.09.28)	현재결과
신장 (cm)	169.5	169.2
체중 (kg)	68.9	68.1
체질량지수(BMI) (kg/m ²)	24	23.8
허리둘레 (cm)	86	84.0

신체계측

신체계측(신장, 체중)을 통해 비만도를 측정할 수 있습니다. 비만도를 측정하는 방법 중 하나인 BMI는 체중을 신장으로 나눈 수치입니다. 체지방량과 관련이 높고 상대적으로 키의 영향을 적게 반영해 비만도 측정에 가장 많이 사용됩니다.

$$\text{BMI} = \text{체중(kg)} \div \text{신장(m)}^2$$

저 체 중	18.5 미만
정 상	18.6 이상 ~ 23 미만
과 체 중	23 이상 ~ 25 미만
비 만	25 이상 ~ 30 미만
고 도 비 만	30 이상

체성분

체성분 검사란 몸에 있는 수분, 단백질, 지방 등의 비율을 확인하는 검사입니다. 우리 몸에 약한 전류를 흘린 후 양쪽 손과 발에서 전류의 흐름을 측정함으로써 몸의 구성성분을 간접적으로 측정합니다.



소견

허리둘레 정상

 기초검사

혈압검사

검사명	중전결과(24.09.28)	현재결과
수축기혈압 120이하	130	138 ↑
이완기혈압 80이하	82	89 ↑
※혈압	전단계고혈압	전단계고혈압
맥박수	74	74

120이상: 고혈압 전단계
140이상: "
80이상: 고혈압 전단계
90이상: 고혈압

혈압

혈압검사는 안정 상태에서 수축기와 이완기의 혈압을 측정합니다. 혈압은 운동, 스트레스, 안정 상태 등에 따라 변하므로 한 번의 측정으로 고혈압을 진단할 수는 없습니다. 혈압이 높게 측정된 경우 가정에서 주기적으로 혈압을 측정해서 확인하는 것이 필요하며 가정에서도 계속 높을 경우 혈압 확인을 위해 병원진료 및 24시간 활동혈압측정 등의 검사가 필요할 수 있습니다.

 소견

혈압 검사 결과 고혈압 전단계(120/80mmHg~139/89mmHg)입니다. 혈압은 측정 시마다 변하는 것이 정상이며 고혈압 진단을 위해서는 반드시 안정 상태에서 혈압을 측정해야 합니다. 고혈압 전단계는 고혈압으로 진행할 가능성이 높으나 안정 상태에서 혈압이 측정되지 않았을 가능성도 있으므로 규칙적인 운동 및 저염식이 등 생활습관 관리하시고 주기적으로 편안한 상태에서 혈압을 측정하시기 바랍니다.

기초검사

안과 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
교정시력(좌)		0.7
교정시력(우)		0.9
※안압검사	정상	정상
안압검사(좌안)	16	14
안압검사(우안)	12	12
※ 안저검사(AI분석)	망막변성 의심 및 드루젠 또는 삼출반 의증 (좌안)	이상소견 의심

소견

안압 검사상 정상입니다.

인공지능 AI 분석(식품의약품안전처 허가)을 바탕으로 한 안저검사 결과 좌안 망막 질환이 의심됩니다. 이는 특별한 치료가 필요 없는 초기 변화일 수도 있지만, 실제로 치료나 관리가 필요한 안과 질환일 수 있습니다. 따라서 정확한 진단과 적절한 관리를 위해 안과 진료를 권유드립니다.

	망막질환의심	녹내장의심	백내장의심
우안	정상범위	정상범위	정상범위
좌안	이상소견 의심	정상범위	정상범위

안압검사

안압검사는 안압 상승을 동반하는 녹내장을 조기에 선별할 수 있는 검사입니다. 하지만 안압 상승만으로 녹내장을 진단할 수 없으며 정상 안압 녹내장도 흔하기 때문에 안저 촬영 결과를 같이 참고해야 하며 증상이 있는 경우 반드시 안과 진료가 필요합니다.

안저 검사

안저는 눈안쪽에 있는 부위로 망막과 혈관, 맥락막, 뇌로 이어지는 시신경의 출입구 등이 존재합니다. 안저 촬영을 통해 실명의 주된 원인인 망막질환, 녹내장, 백내장을 초기에 발견할 수 있습니다.

안저 검사 대상질환

망막질환, 녹내장, 백내장

 기초검사

청력 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
청력검사	청력 정상	청력 정상
청력 500Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)
청력 1000Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)
청력 2000Hz(좌/우)	20 / 20(dB)	20 / 20(dB)
청력 4000Hz(좌/우)	35 / 20(dB)	20 / 20(dB)

청력검사
청력은 각 주파수마다 25dB 이상인 강도의 소리만 들을 수 있는 경우 이상이 있다고 판정하며, 주파수에 따라 다르지만 40dB 이상인 높은 강도의 소리만 들을 수 있는 경우에는 일상 생활에 지장이 있을 수 있습니다.

 소견

청력 정상

당뇨 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
공복혈당	107	▲ 107			

당뇨 검사 임상 참고치	
공복혈당	70 ~ 99mg/dl

 소견

혈당이 정상보다 다소 높지만 당뇨병 진단기준에 비해서는 낮아 공복시 혈당장애로 분류됩니다. 정상체중 유지 및 지속적인 운동하시고 3개월 후 재검하여 추적관찰 하십시오.

당뇨검사
당뇨병의 진단기준은 공복 혈당 126mg/dL 이상이거나 당화혈색소가 6.5% 이상인 경우입니다. 공복혈당이 100~125mg/dL 또는 당화혈색소 5.7~6.4%인 경우에는 당뇨병 전 단계(공복 혈당 장애)로 진단하며, 향후 당뇨병으로 진행될 가능성이 높습니다. 따라서 당뇨병 전 단계(공복 혈당 장애)에 해당하는 경우에는 식이조절, 운동 및 체중조절 등의 건강한 생활 습관을 유지하기 위한 노력을 기울여야 하며 정기적인 혈당검사를 받아야 합니다.



기초검사

대사증후군

	종전결과(24.09.28)	현재결과
수축기혈압	130	138
이완기혈압	82	89
공복혈당	107	107
중성지방(Triglyceride)	43	52
HDL-Cholesterol	57	56
허리둘레	86	84.0

소견

귀하는 위의 항목 중 기준치가 넘는 항목이 두 가지 이하(혈당 장애, 혈압)이므로 대사증후군으로 진단되지는 않습니다만 건강한 생활을 위하여 대사증후군에 대한 내용을 참고하시고 1년 뒤 추적관찰 하시기 바랍니다.
※ 혈압 및 HDL, 중성지방, 공복혈당의 경우 수치가 정상이어도 해당 약물 복용 시 기준치가 넘는 항목으로 분류되오니 참고 바랍니다.

혈관

대사증후군

대사증후군이란, 심뇌혈관질환 및 당뇨병의 위험을 높이는 체지방 증가, 혈압 상승, 혈당 상승, 혈중 지질 이상 등의 이상 상태들의 집합을 말합니다. 대사증후군이 있는 경우에는 심혈관 질환의 위험을 두 배 이상 높이며, 당뇨병의 발병을 10배 이상 증가시킵니다. 이러한 대사증후군은 단일한 질병이 아니라 유전적 소인과 환경적 인자가 더해져 발생하는 포괄적 질병입니다.

대사증후군 검사

일반적으로 아래의 기준 중 세 가지 이상 해당이 되면 대사증후군으로 정의합니다.

- ① 복부비만: 허리둘레 남자 90cm, 여자 85cm 이상
- ② 고중성지방혈증: 중성지방 150mg/dL 이상 또는 고중성지질혈증을 치료하기 위해 약물 투여 중인 상태
- ③ 낮은 HDL 콜레스테롤 혈증: 남자 40mg/dL, 여자 50mg/dL 미만 또는 고지질혈증약을 복용하는 경우
- ④ 높은 혈압: 130/85mmHg 이상 또는 고혈압약을 복용하는 경우
- ⑤ 혈당 장애: 공복 혈당 100 mg/dL 이상 또는 당뇨병 과거력, 또는 약물 복용

중성지방 / HDL 비율

24년
0.95

25년
0.92

1 이하 = 최적
2 = 낮은 위험
3 = 중간 위험
4 = 고위험

심혈관 질환
예방

 순환기

심전도검사(일반)

	종전결과(23.11.04)	현재결과
심전도검사(일반)	정상	정상

 소견
정상

심전도검사(일반)

심전도는 심장의 전기 에너지를 체표면에 부착한 전극을 통해 그래프를 기록해 나타내주는 검사입니다. 심장 질환에 대한 다양한 정보를 얻을 수 있으며 특정 질환을 의심할 수 있는 소견이 보이는 경우 순환기내과 진료가 필요합니다.

동맥경화도 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
ABI(협착)좌	1.15	1.15
ABI(협착)우	1.16	1.17
baPWV(좌)	1675	▲ 1701
baPWV(우)	1646	▲ 1604
※동맥경화도검사	동맥경화의 관리범주	동맥경화의 관리범주

 소견

말초혈관 동맥경화 검사(혈류 속도 측정)에서 동맥경화의 관리범주에 속합니다. 흡연시에는 금연하시고, 일상생활에 주의(체중조절, 저지방식이, 운동)가 필요하며, 정기적인 추적검사 요합니다.

동맥경화도 검사 참고치

ABI(협착)좌	0.9 ~ 1.4
ABI(협착)우	0.9 ~ 1.4
baPWV(좌)	0 ~ 1299
baPWV(우)	0 ~ 1299
※동맥경화도검사	정상

동맥경화도 검사

동맥경화증은 혈관 내벽에 콜레스테롤 중성지방 석회등이 침착되어 혈관이 좁아지거나 동맥벽이 딱딱해져 뇌졸중 심근경색등을 유발하는 질환입니다. 동맥경화 검사는 맥파속도와 팔다리 혈압차를 측정하여 동맥의 경직도와 협착도를 알아보는 검사입니다.

심혈관질환예측

총콜레스테롤 / HDL 비율
3.5 이하 = 최적
3.5 ~ 5.0 = 중간위험
5.0 이상 = 고위험
24년
2.5

25년
3.4

 순환기

경동맥 초음파 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
경동맥초음파	좌측 총경동맥 분기부 플라그	좌측 내경동맥 내막비후 / 좌측 총경동맥 분기부 플라그

경동맥 초음파 검사

초음파를 이용해 목 부위 주요 동맥의 상태를 확인하는 검사로, 경동맥의 비대 여부, 플라크 존재 여부, 협착 상태 등을 평가할 수 있습니다. 이 검사를 통해 동맥경화 등으로 인한 경동맥 협착 여부를 직접 확인할 수 있으며, 간접적으로 뇌혈관 건강 상태도 파악할 수 있습니다.

 소견

경동맥초음파 검사에서 좌측 내경동맥의 내막이 비후되어 있습니다. 이는 뇌혈관 및 심혈관질환의 위험 인자 이므로 금연 및 당뇨, 체중,콜레스테롤, 혈압 조절이 필요하며 정기적인 경동맥 초음파 및 고지혈증 검사로 확인 바랍니다.

경동맥초음파 검사에서 좌측 총경동맥 분기부 내 플라그가 관찰됩니다. 뇌혈관 및 심혈관 질환의 위험인자 이므로 금연 및 당뇨, 체중, 콜레스테롤, 혈압조절이 필요합니다. 정기적 추적검사를 요합니다.

지질 및 심혈관 혈액검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
총콜레스테롤(T-Cholesterol)	146	193			
중성지방(Triglyceride)	43	52			
HDL-Cholesterol	57	56			
LDL-Cholesterol	80	127			

지질 및 심혈관 임상 참고치

총콜레스테롤(T-Cholesterol)	120 ~ 199mg/dl
중성지방(Triglyceride)	50 ~ 149mg/dl
HDL-Cholesterol	40 ~ 60mg/dl
LDL-Cholesterol	50 ~ 129mg/dl

 소견

LDL-콜레스테롤은 심혈관질환 발생의 주요한 위험인자입니다. 현재 수치가 높지 않으므로 특별한 임상적 의의는 없을 것으로 사료됩니다. 하지만 당뇨병 또는 혈관질환을 앓고 계신 경우에는 더 낮게 조절해야 하므로 필요시 전문의와 상담하십시오.

지질 및 심혈관 혈액 검사

지질 검사 중 HDL-콜레스테롤은 동맥경화 예방효과가 있으므로 기준치 보다 높을수록 좋으며, LDL-콜레스테롤, 총 콜레스테롤, 중성지방은 높을수록 동맥경화를 악화 시키므로 기준치 이하로 유지되도록 노력해야 합니다.

지질 혈액 검사 대상질환

심근경색증, 동맥경화증, 고지혈증

혈관

HDL 60대상
유지 권장

지방 섭취 증가 LDL 증가 경향.



갑상선 초음파 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
갑상선 초음파	특이소견없음	특이소견없음
소견	특이소견없음	

갑상선 초음파
갑상선 초음파 검사는 초음파를 이용하여 갑상선의 내부 구조와 주위 조직을 확인하고 갑상선 내 혹(결절)의 모양,크기,상태를 확인합니다.

갑상선 기능 혈액검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
※ TSH	3.04	3.45		■	

[※] 표시 항목은 검사방법 변경으로 인해 기준치가 종전결과와 상이함.

갑상선 기능 임상 참고치	
TSH	0.35 ~ 5.5uIU/mL

소견	정상
----	----

갑상선 기능 혈액 검사
Free T4(갑상선호르몬) 감소 시에는 갑상선 기능 저하증을, 증가 시에는 갑상선 기능 항진증을 의미합니다.
TSH(갑상선자극호르몬)는 뇌하수체에서 분비되어 갑상선의 기능을 조절합니다. 갑상선의 기능이 저하될 때 증가하고, 항진될 때 감소합니다.

갑상선 기능 혈액 검사 대상질환
갑상선기능 저하증, 갑상선 기능 항진증



흉부 X-ray

	종전결과(24.09.28)	현재결과
흉부직접촬영	단순 소폐결절,우상	섬유흔, 우상

흉부 X-ray 검사

X-ray를 이용하여 폐 부위와 심장, 종격동, 횡격막 및 쇄골, 늑골, 흉추 등의 이상을 가장 간단하게 확인할 수 있는 검사입니다.

소견

흉부촬영상 우상의 비활동성 섬유흔 소견 입니다. 이전 염증등에 의한 변화로 현재 임상적 의의는 없으며 정기적인 검사를 하시기 바랍니다.



대장 내시경 검사

	종전결과()	현재결과
대장 내시경		용종(용종절제술-CPP)

소견

대장내시경 검사상 (횡행결장)부위에 약 (3)mm 크기의 용종 (1)개 발견되어 올가미를 이용하여 용종절제술 시행하였고 조직검사 결과 (저도이형성 관상선종)으로 진단되었습니다. 이는 양성종양으로 제거된 상태이므로 더이상의 치료는 필요하지 않으나 경과관찰을 위해 3년 후에 대장내시경 추적검사 필요합니다.

대장 내시경 검사
항문으로 내시경을 삽입하여 대장 및 대장과 인접한 소장의 말단 부위까지 관찰하는 검사입니다. 대장 내시경은 대장암과 염증성 장질환의 진단에 매우 중요한 검사로서 직접 대장의 내부를 보면서 진단합니다. 필요에 따라 지혈을 하거나 조직 검사 또는 의심스러운 병변을 제거하는 치료 목적을 동반하는 정밀 검사입니다.

간, 담도, 췌장

간, 담도, 췌장 영상

	종전결과(24.09.28)	현재결과
복부초음파	간 우엽 내 석회화 / 수축담낭 / 지방간 경증	간 우엽 내 석회화 / 담낭 용종(0.3cm) / 지방간 경증

복부 초음파 검사

복부 초음파 검사는 초음파를 이용하여 상복부에 있는 간, 신장(콩팥), 담낭(쓸개), 췌장, 비장의 이상을 확인하는 검사로 상복부 내 여러 장기를 비교적 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 장점이 있으나, 복부 내 가스 유무 등에 따라 검사 진행이 어려울 수 있습니다.

소견

- 복부초음파 검사에서 경도의 지방간이며 간세포 내에 지방이 과다 축적된 상태를 말합니다. 비만, 과음, 운동부족, 당뇨 등이 주원인으로 알려져 있습니다. 지방식을 줄이시고 적당한 운동이 필요합니다.
- 복부초음파 검사에서 담낭 용종(0.3cm)이 관찰됩니다. 담낭 용종은 담낭의 안쪽 벽에서 안으로 돌출된 다양한 형태의 점막용기를 말하며 1cm미만은 크기가 작아 임상적인 의의가 없으므로 정기적인 추적검사를 통해 모양 및 크기 변화를 관찰하시기 바랍니다.
- 복부초음파 검사에서 간 우엽 내 석회화가 보입니다. 석회화의 원인은 뚜렷하지 않으나 대부분 간세포나 조직 내에 칼슘이 침착된 것으로 별다른 임상적 의의는 없습니다.

간, 담도, 췌장

간, 담도, 췌장 혈액 및 간염바이러스

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
총단백(T.Protein)	7.0	7.3			
알부민	4.2	4.4			
글로불린(Globulin)	2.8	2.9			
A/G 비율	1.5	1.5			
총빌리루빈	0.7	0.7			
직접빌리루빈	0.2	0.3			
간접빌리루빈	0.5	0.4			
AST(SGOT)	25	25			
ALT(SGPT)	20	18			
γ-GTP	31	25			
Alk.Phosphatase(ALP)	61	63			
Amylase	75	90			
HBs Ag(정량)	음성 (<0.10)	음성 (0.12)			
HBs Ab(정량)(CLIA)	양성 (144.80)	양성 (157.43)			

소견

B형 간염에 대한 항체(HBsAb)가 양성으로 면역이 형성된 상태입니다.

간염 바이러스 결과 의미

검사항목	결과의미
B형간염 표면항체(HBs Ab)	양성 : B형간염 면역상태 음성 : B형간염 비면역 상태
B형간염 항원(HBs Ag)	양성 : B형간염 바이러스 보유 음성 : B형간염바이러스 미보유
A형 간염 항체(HAV Ab)	양성 : 과거 A형 간염 감염 또는 백신접종으로 인한 면역 상태
C형 간염 항체(anti-HCV)	양성 : 현재 C형 간염 바이러스 보유 또는 과거 감염 상태

※ 해당 설명은 결과가 아닌 이해를 돕기 위한 참고 자료입니다.

간, 담도, 췌장 임상 참고치

총단백(T.Protein)	6.0 ~ 8.3 g/dl
알부민	3.5 ~ 5.2 g/dl
글로불린(Globulin)	1.5 ~ 3.0 g/dl
A/G 비율	1.3 ~ 2.3
총빌리루빈	0.2 ~ 1.2 mg/dl
직접빌리루빈	0.0 ~ 0.5 mg/dl
간접빌리루빈	0.2 ~ 0.7 mg/dl
AST(SGOT)	0 ~ 40 IU/L
ALT(SGPT)	0 ~ 45 IU/L
γ-GTP	11 ~ 70 IU/L
Alk.Phosphatase(ALP)	40 ~ 150 IU/L
Amylase	16 ~ 109 U/L
HBs Ag(정량)	음성<1 1≤약양성≤49.99 양성≥50
HBs Ab(정량)(CLIA)	음성<10 10≤약양성≤29.99 양성≥30 (mIU/mL)

간 기능 혈액 검사

간, 담도, 췌장은 해부학적으로 매우 인접해 있을 뿐 아니라 간에서 만들어진 담즙이 담도로 내려가고 췌장에서 만나 십이지장으로 분비되기 때문에 서로 유기적인 연결 관계에 있습니다. 혈액 검사와 간염 검사를 통해 간, 담도, 췌장의 질환 여부를 파악하게 됩니다.

간 기능 혈액 검사 대상 질환

간염, 간경변증, 간질환, 담도질환 등

신장요로

신장/요관/방광 X-ray

종전결과()	현재결과
KUB(신장,요관,방광)	정맥석의심

신장/요관/방광 X-ray 검사

X-ray를 이용해 콩팥, 요관, 방광 부위를 촬영하는 검사로 신장과 방광의 크기, 모양, 위치를 확인 할 수 있습니다. 요로 결석, 협착 등을 확인하는데 도움이 됩니다.

소견

KUB(신장, 요관, 방광)촬영에서 골반강내 정맥석이 의심됩니다. 현재 임상적 의의는 없으므로 정기적인 추적 관찰을 요합니다.

신장 기능 혈액검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
요소질소	10	13			
Creatinine	0.9	0.80			
BUN/Cr 비율	11.1	16.3			
사구체여과율(GFR)		99			

신장 기능 혈액검사 임상 참고치

요소질소	5 ~ 20mg/dl
Creatinine	0.50 ~ 1.40mg/dl
BUN/Cr 비율	10 ~ 20%
사구체여과율(GFR)	60 ~ 10000

소견

정상

신장 기능 혈액 검사

신장은 우리 몸속에서 노폐물을 제거하는 기능을 하며 요소질소와 크레아티닌은 신장의 기능과 연관된 지표입니다. 요소질소는 탈수와 같은 일상적인 상황에서도 흔하게 상승하기 때문에 반드시 크레아티닌 검사 결과와 같이 해석해야 하며, 크레아티닌이 증가한 경우에는 신장 기능에 문제가 있을 가능성이 크기 때문에 신장 내과 진료가 필요합니다.

신장 기능 혈액 검사 대상질환

신장질환, 신부전, 탈수 등

신장요로

소변검사

	중진결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음	소변검사 임상 참고치	
요중백혈구(WBC)	-	-				요중백혈구(WBC)	-,±
요중Nitrite	-	-				요중Nitrite	-
요비중(SG)	1.021	▼ 1.002				요비중(SG)	1.005 ~ 1.030
pH (요검사)	5.5	5.0				pH (요검사)	5.0 ~ 8.0
요단백	-	-				요단백	-
당(요검사)	-	-				당(요검사)	-
요중케톤체량	-	-				요중케톤체량	-,±
유로빌리노겐	±	±				유로빌리노겐	-,±
요빌리루빈	-	-				요빌리루빈	-
요잠혈	±	-				요잠혈	-,±

소견

소변 검사 결과상 임상 참고치(정상치)에서 다소 벗어나는 소견이 있으나 임상적으로 특별한의의는 없을 것으로 생각합니다. 정기적인 추적관찰을 권하며, 필요 시 전문의 상담을 요합니다.

소변 검사
소변 검사 상 단백뇨와 혈뇨는 심한운동, 약물치료, 생리 등에 의해서도 일시적으로 나타날 수 있지만 반복된 검사에도 단백뇨와 혈뇨가 지속되고 당뇨, 고혈압과 같은 신기능 장애를 유발하는 기저 질환이 있다면 신장질환이 동반되었을 가능성이 매우 높으므로 신장 내과 진료가 필요합니다. 소변에서 관찰되는 백혈구는 임상적 의의는 크지 않지만 질 분비물이 오염되거나 요로 감염 시 나타날 수 있기 때문에 관련된 증상이 있는 경우 관련 전문의 진료가 필요합니다.

소변 검사 대상질환
당뇨병, 요로감염, 신장질환, 방광암 등

 혈액

혈액학 & 철대사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
혈색소량(Hb)	13.5	14.7			
혈구용적치(HCT)	39.7	42.6			
※ 적혈구수	403	4.37			
적혈구용적(MCV)	98.5	97.5			
적혈구혈색소량(MCH)	33.5	33.6			
적혈구혈색소농도(MCHC)	34.0	34.5			
RDW	12.8	12.9			
백혈구수	4.96	5.32			
분획호중구	54	46			
림프구	32	41			
단핵구	10	8			
호산구	3	4			
호염기구	1	1			
※ 혈소판수	24.8	253			
PDW	10.5	11.9			
MPV	9.8	10.2			
Fe	134	▲ 182			

[※] 표시 항목은 단위 변경으로 인해 기준치가 종전결과와 상이함.

 소견

혈액 검사 결과상 임상 참고치(정상치)에서 다소 벗어난 소견이 있으나
임상적으로 특별한 의의는 없을 것으로 생각됩니다. 건강을 위하여 과로와
스트레스를 피하도록 하십시오.

혈액학 & 철대사 검사 임상 참고치

혈색소량(Hb)	13.0 ~ 17.3g/dL
혈구용적치(HCT)	38.0 ~ 50.2%
적혈구수	4.20 ~ 5.80x10 ⁶ /μL
적혈구용적(MCV)	84.0 ~ 99.4fL
적혈구혈색소량(MCH)	28.0 ~ 34.0pg
적혈구혈색소농도(MCHC)	32.0 ~ 36.0g/dl
RDW	11 ~ 14.5%
백혈구수	3.8 ~ 10.2x10 ³ /μL
분획호중구	36 ~ 70%
림프구	21 ~ 50%
단핵구	3 ~ 11%
호산구	0 ~ 9%
호염기구	0 ~ 1%
혈소판수	140 ~ 365x10 ³ /μL
PDW	9.6 ~ 15.5FL
MPV	9.0 ~ 12.0fL
Fe	60 ~ 175ug/dl

일반 혈액 검사

일반 혈액검사는 혈액 내 존재하는 세가지 종류의 세포, 즉 적혈구, 백혈구, 혈소판의 양 및 특성을 평가하는 검사로 전반적인 건강상태를 나타내며, 다양한 질환의 선별 검사와 추적 관찰에 이용됩니다.

일반 혈액 검사 대상질환

적혈구 증가&감소, 백혈병 등

빈혈

빈혈 검사는 빈혈의 원인을 확인하기 위한 검사입니다. 철은 적혈구 생성에 필수적인데, 생리량이 많거나 위장관 출혈 등으로 체외로 혈액이 빠져나가면 철분도 함께 손실됩니다. 이로 인해 적혈구 생성이 어려워지며 철결핍성 빈혈이 발생합니다. 이 경우 혈중 철분과 페리틴(Ferritin)이 감소하고, 총철결합능(TIBC)은 증가하는 특징이 나타납니다.

종양표지자

종양표지자 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
CEA	< 0.50	< 0.50			
AFP(E)-수치	2.52	3.50			
PSA (남자)	0.63	0.67			

종양표지자 검사 임상 참고치	
CEA	0 ~ 5.00 ng/mL
AFP(E)-수치	0.00 ~ 8.09 ng/ml
PSA (남자)	0 ~ 4.00 ng/mL

소견

CEA 검사상 정상범위내에 있습니다. CEA는 대장암 및 폐암에 대한 종양 표지자 검사이나 진단에 보조적 방법으로 선별검사나 확진검사는 아니므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

AFP 검사상 이상이 없습니다. AFP는 간암, 만성간염 등에 대한 종양표지자이나 이는 복부초음파검사 등 다른 진단적 방법에 대한 보조적 검사로서 확진 또는 선별검사는 아닙니다. 그러므로 상기질환 의심시 정상범위라 할지라도 반드시 전문의와 상담하십시오.

PSA(전립선 특이항원) 검사상 이상이 없습니다. PSA는 전립선암, 전립선 비대증과 같은 전립선 질환에서 증가하나 진단을 위한 보조적 방법으로 확진 또는 선별 검사는 아닙니다. 따라서 상기질환 의심시 비록 정상범위라해도 반드시 전문의 상담을 요합니다.

혈액 종양표지자 검사

종양표지자는 암 발생 시 혈액 내 상승하는 표지자로 암의 조기진단 및 치료 후 치료 경과 관찰에 사용됩니다. 다만 암이 아닌 일반 질환이나 정상적인 신체 변화에도 높게 나타나는 경우가 많고 종양표지자 상승만으로 암을 진단하는 것은 불가능하기 때문에 정상치 보다 현저히 높게 나타난 경우는 관련된 암에 대한 전문의 진료가 필요합니다.



통풍 및 면역매개질환

통풍 및 염증 반응 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
요산(Uric Acid)	5.1	4.8		■	

통풍 및 염증 반응 검사 임상 참고치

요산(Uric Acid) 3 ~ 8mg/dl



소견

정상

염증 혈액 검사

CRP, ESR 상승은 감염, 자가면역질환, 악성 종양과 같은 인체 내에 감염이나 염증반응이 있을 때 상승하지만 별다른 질환이 없거나 비염 증상 질환에서도 약간 높게 나타나는 경우가 혼합니다. CRP, ESR 상승과 동반하여 발열이나 국소 감염 증상이 있는 경우 관련 전문의 진료가 필요합니다.

요산, 류마티스 인자

요산은 퓨린체가 체내에서 분해되어 생기는 최종 산물로 주로 신장에서 여과되어 소변으로 배출됩니다. 요산의 과잉 생산 혹은 배설 장애가 있는 경우 혈액에서 기준치 이상으로 상승하여 통풍, 신장 및 요로결석의 원인이 되기도 합니다.

류마티스 인자는 자가면역항체의 일종입니다. 별다른 질환이 없는 사람에게 양성이 나오는 경우가 대부분이지만 류마티스 관절염이나 여러 류마티스 질환에서 양성으로 나타나는 경우가 있기 때문에 류마티스인자 양성이고 관절 증상이 있는 경우 류마티스내과 진료가 필요합니다.

요산, 류마티스 인자 대상질환

통풍, 류마티스 관절염, 백혈병 등

수검자 : 유지우



근골격

골대사 및 부갑상선

	종전결과(24.09.28)	현재결과	낮음	정상	높음
혈청인(P)	3.7	3.3			
혈중 칼슘	8.6	9.1			

골대사 및 부갑상선 임상 참고치

혈청인(P)	2.5 ~ 4.5mg/dl
혈중 칼슘	8.2 ~ 9.6mg/dL



소견

정상



뇌·신경

스트레스검사(심박변이도)

	종전결과(24.09.28)	현재결과
심박변이도(스트레스검사)	종전 결과지 참고	별도 결과지 참고



소견

[별도 결과지 참고]



자율신경균형검사

스트레스검사

AUTONOMIC BALANCE REPORT

Name

유지우

Chart No.

0009918851

Sex/Age

M / 56

Date

2025-10-17 08:30

자율신경 균형검사

차세대 Vital sign=HRV를 이용한 자율신경 균형 및 스트레스 검사

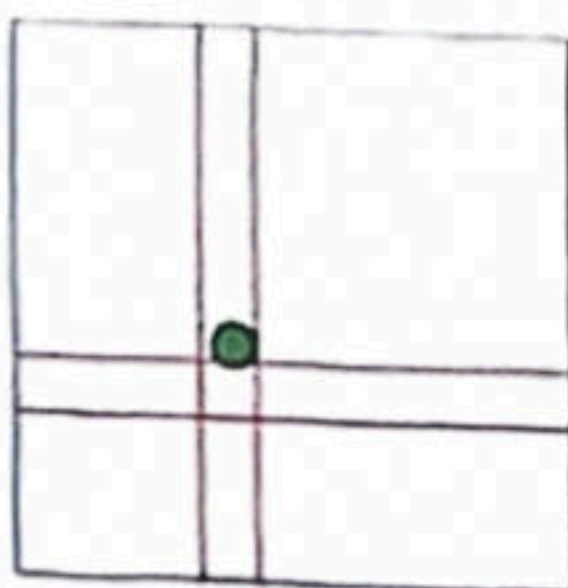
본 검사는 우리의 신체 조절 능력과 스트레스 저항도 및 피로도 등 전반적인 건강 상태를 확인 할 수 있는 최신 검사 방법입니다.

자율신경계

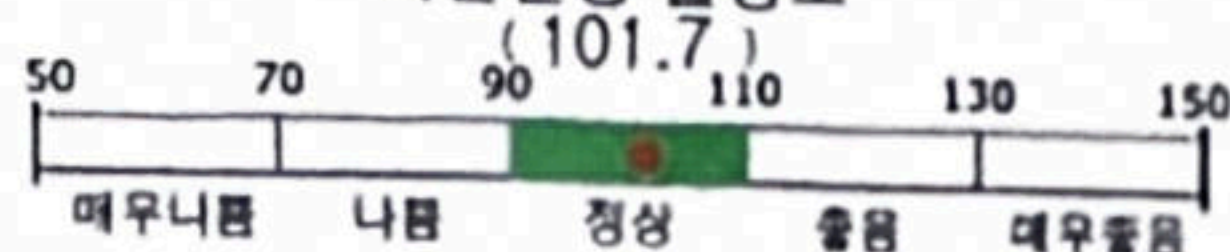


자율신경계란 주로 내장 기관에 분포하는 신경으로 교감신경과 부교감신경으로 구성되어 있으며, 신체불균형 상태를 교정하고 평형을 유지 시켜주는 기능을 담당하고 있습니다.

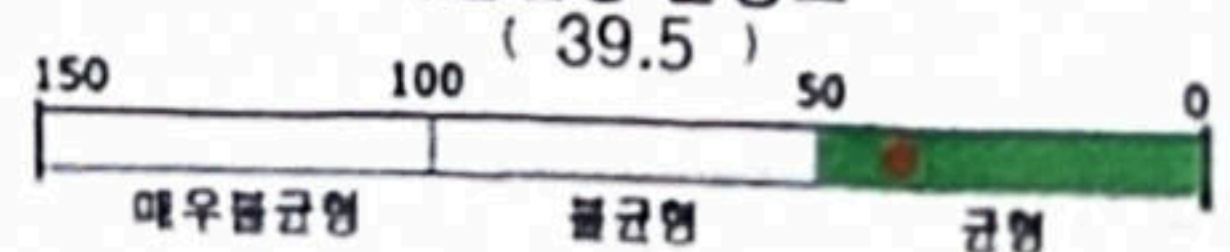
자율신경 안정도



자율신경 활성화도



자율신경 균형도



스트레스

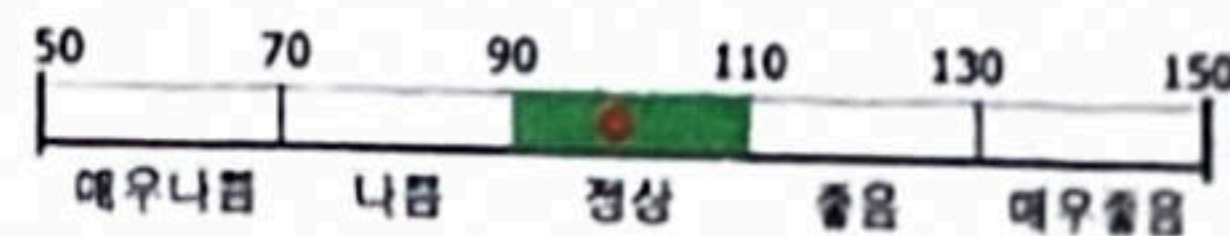
스트레스란 내적으로 긴장감을 느끼게 하는 것으로서, 외부로부터 오는 압력을 말합니다. 적당한 스트레스는 생활의 촉진제일 수 있으나, 과도한 스트레스는 몸과 마음에 커다란 영향을 미칩니다.



일반적으로 병원에서 시행하는 검사상 특별한 이상을 발견하기 어려운 만성피로, 불면, 소화기계의 이상 등과 같은 질환은 대부분 스트레스와 관련되어 있습니다.

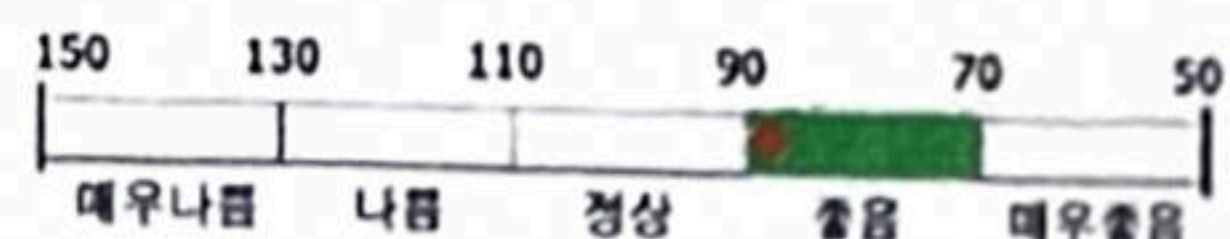
스트레스 저항도

(99)



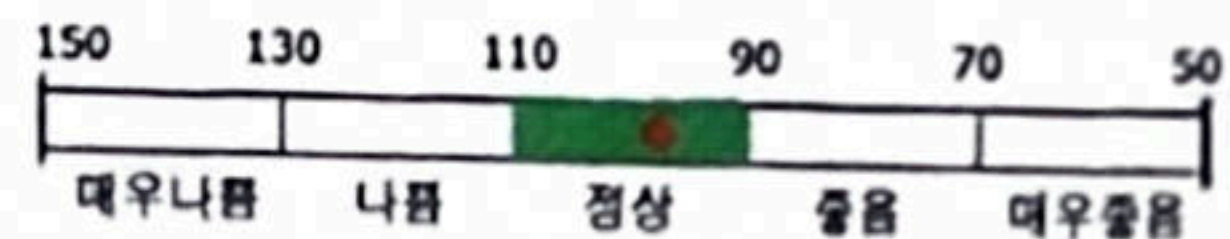
스트레스 지수

(88)

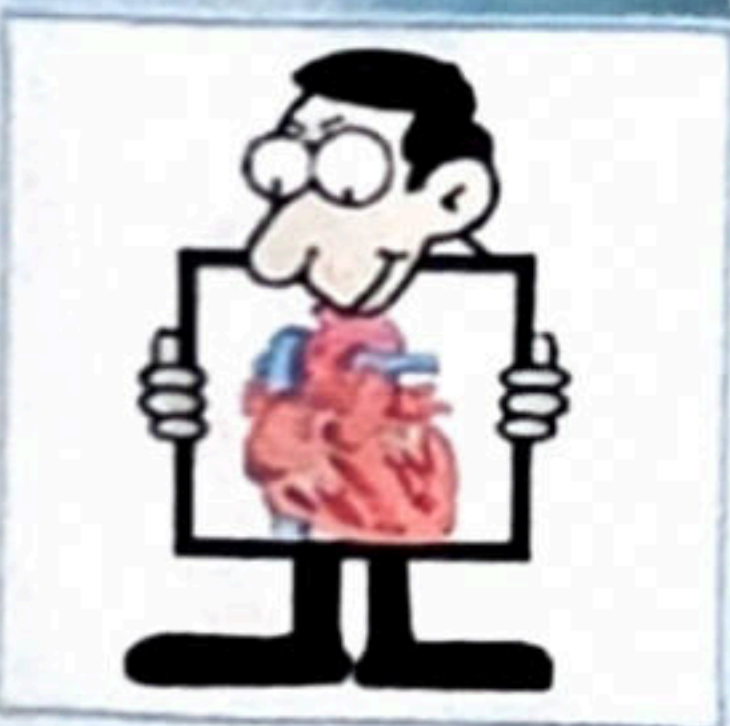


피로도

(97.3)



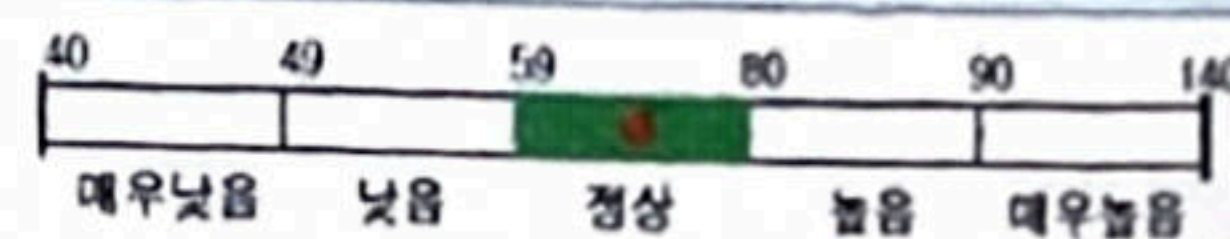
심장



심장은 피를 전신에 순환시켜 산소와 영양소를 공급하고, 지속적이고 안정적으로 움직이고 있습니다. 스트레스는 자율신경계의 기능을 저하시키고, 이는 심장의 안정도를 떨어뜨려 각종 질병을 야기하는 원인이 됩니다.

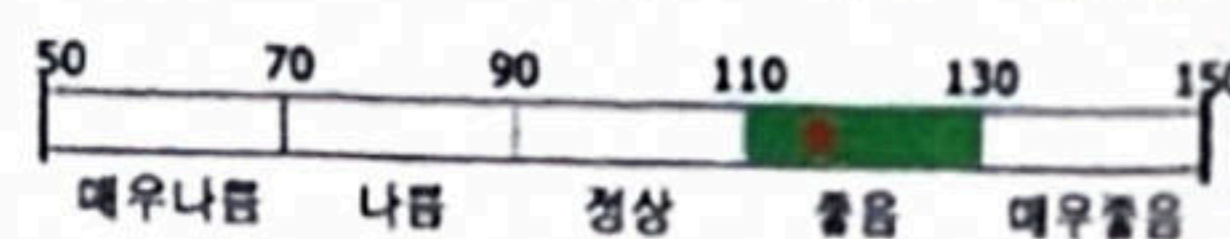
평균 심박동수

(70)



심장 안정도

(116.5)



이상 심박동수

(0 회)

검사소견

Medicore : 02-1234-5678

정상적인 심박수 상태입니다.

1. 자율신경계

- 1) 자율신경활성도 : 자율신경의 기능과 인체의 조절능력이 정상입니다.
- 2) 자율신경균형도 : 자율신경의 활동이 균형을 이루고 있으며 안정된 상태입니다.

2. 스트레스

- 1) 스트레스 저항도 : 스트레스에 대한 대처능력이 좋은 상태로 꾸준한 건강관리를 통하여 현재의 상태를 유지토록 바랍니다.
- 2) 스트레스 지수 : 스트레스 정도가 좋은 편입니다.
- 3) 피로도 : 피로도가 보통수준 입니다.

DDR v5.0.0



남성의학

전립선 초음파 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
전립선 초음파	전립선 내 석회화	전립선 내 석회화

전립선 초음파 검사

전립선 초음파 검사는 방광에 소변을 채우고 복부를 통해 시행하는 경복부초음파 검사입니다. 전립선의 내부 구조와 주위 조직을 확인하여 전립선 비대증이나 전립선 질환 등을 확인하며, 방광 및 전립선의 이상을 진단하는 데 유용한 검사입니다.



소견

전립선초음파 검사에서 전립선의 일부가 석회화된 소견이 있습니다. 전립선 석회화는 비교적 흔한 소견으로서 임상적으로 문제가 되는 질환은 아니므로 정기적인 추적검사만을 요합니다.

성매개감염병(남) 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
RPR 정밀(매독)	음성	음성

성매개감염병(남) 검사 임상 참고치

RPR 정밀(매독)	음성
------------	----



소견

정상

기타 검사

기타 외부 검사

	종전결과(24.09.28)	현재결과
건강성적표	별도 결과지 참고	별도 결과지 참고
Cogmate(뇌건강 측정)	별도 결과지 참고	별도 결과지 참고

소견

별도 결과지 참고 - 건강성적표, Cogmate(뇌건강 측정)

일반건강검진 결과통보서

유지우 님은 올해 공단일반검진 비대상입니다. 이 결과지는 결과 확인을 위한 참고용입니다. 확진검사는 불가합니다.

한미글로벌

수검자 성명 유지우

주민등록번호 681019-1*****

유지우

검진장소 ☒ 내원 ☐ 출장

68.10.19

검진일 2025년 10월 17일

건강검진 종합소견

판정 - ☐ 정상 A ☒ 정상 B (경계)

☐ 일반 질환의심 ☐ 고혈압 · 당뇨병 · 이상지질혈증 질환의심

☐ 유질환자

◆ 유지우 님은 일반건강검진 검사를 받으셨습니다.

※ 흉부촬영검사는 폐결핵 진단검사이며, 폐암 선별검사는 아닙니다.

◆ 유지우 님은 다음 사항에 대한 관리가 필요합니다.

▷ 의심 질환 :

해당사항없음

※ □고혈압, □당뇨병, □폐결핵, □우울증, □조기정신증, □C형간염이 의심되는 분은 병·의원((상급)종합 · 치과 · 한방 · 요양 · 정신병원, 치과 · 한의원 제외)에서
검진받은 연도의 다음연도 1월 31일까지 최초 1회 본인부담 없이 진료(아래 각주 참고)가 가능하니 꼭 받으시기 바랍니다

* 고혈압 : 진찰, 혈압측정 * 당뇨병 : 진찰, 공복혈당검사
* 정신건강검사(우울증, 조기정신증), C형간염 : 별도 안내문 참조(첫 진료비 지원 대상 관련)
* 폐결핵((상급) 종합병원 포함) : 진찰, 객담 (가래) 도말검사 및 배양검사, 핵산증폭검사

▷ 유질환 :

해당사항없음

▷ 생활습관 관리 :

* 고위험 음주 상태입니다. 절주 또는 금주가 필요합니다.

▷ 기타 :

* 고혈압 전단계입니다. - 고혈압으로 이환 가능성이 있습니다. 빈번한 혈압체크, 꾸준한 유산소 운동 및 저염식이 등을 통해 관리가 필요합니다.
* 공복혈당 장애입니다. - 관리하지 않으면 당뇨병으로 이환될 수 있습니다. 생활습관 변경(운동, 식이)을 통해 적극적인 관리가 필요합니다.
* 흉부 X-ray 검사 결과 섬유흔, 우상 소견입니다. - 흉부방사선 사진 상 병변이 발견되었으나, 추가 검사나 치료가 필요할 가능성이 낮은 상태입니다.

구분	목표질환	검사항목	결과(참고치)
계측검사사	비만/복부비만	키(cm) 및 몸무게(kg)	169.2cm / 68.1kg
		체질량지수(kg/m ²)	23.8 ☐ 저체중 (18.5 미만) ☒ 정상 (18.5-24.9) ☐ 과체중 (25-29.9) ☐ 비만 (30 이상)
		허리둘레(cm)	84.0 ☒ 정상 ☐ 복부비만 (남90이상 여85이상)
	시각이상	시력(좌/우)	0.7 / 0.9 ☒ 교정
	청각이상	청력(좌/우)	정상 / 정상 ☐ 교정 ☒ 정상 ☐ 질환의심(40dB 이상)
	고혈압 (수축기/이완기)	138 / 89 mmHg	☐ 정상 ☐ 유질환자 ☒ 고혈압 전단계 (수축기 120~139 또는 이완기 80~89) ☐ 고혈압의심(수축기 140 이상 또는 이완기 90 이상)

정밀검사사	빈혈 등	혈색소(g/dL)	14.7	남 13 - 16.5 여 12 - 15.5	☒ 정상 ☐ 기타 ☐ 빈혈의심
	당뇨병	공복혈당(mg/dL)	107	100미만	☐ 정상 ☐ 유질환자 ☒ 공복혈당장애 의심 ☐ 당뇨병 의심
	이상지질혈증 * 당뇨병 동반한 경우 저밀도 C < 100* * 의사판단시 수정 가능	총콜레스테롤(mg/dL)	비대상	200미만	☐ 정상 ☐ 고콜레스테롤혈증 의심 ☐ 고중성지방혈증 의심 ☐ 낮은 고밀도 콜레스테롤 의심 ☐ 유질환자
		고밀도 콜레스테롤(mg/dL)		60이상	
		중성지방(mg/dL)		150미만	
		저밀도 콜레스테롤(mg/dL)		130미만	
	신장질환	혈청크레아티닌(mg/dL)	0.80	1.5이하	☒ 정상 ☐ 신장기능 이상 의심
		신사구체여과율(e-GFR) (mL/min/1.73m ²)	99	60이상	
	간장질환	에이에스티(AST) (IU/L)	25	40이하	☒ 정상 ☐ 간기능 이상 의심
		에이엘티(ALT) (IU/L)	18	35이하	
		감마지티피(γGTP)(IU/L)	25	남 63이하 여 35이하	

요검사	요단백	☒ 정상 ☐ 경계 ☐ 단백뇨 의심
-----	-----	--

영상검사	흉부촬영	☒ 정상 ☐ 비활동성 폐결핵 ☐ 질환의심 : ☐ 기타 :
------	------	--

진찰 (문진)	과거병력	무	약물치료	무
	생활습관	☐ 금연 필요 ☒ 절주 필요 ☐ 신체활동 필요 ☐ 근력운동 필요 * 담당 의사와 상담하십시오.		

	실시대상자 여부	결과
B형 간염	☐ 해당 ☒ 비해당	표면항원 ☐ 일반 ☐ 정밀 () 표면항체 ☐ 일반 ☐ 정밀 () ☐ 항체있음 ☐ 항체없음 ☐ B형 간염 보유자 의심 ☐ 판정보류
		☐ 일반 ☐ 정밀 () ☐ 항체 있음 (C형간염 의심, 확진검사 필요) ☐ 항체 없음
C형 간염	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 우울증상이 없음(0~4점) ☐ 가벼운 우울증상(5~9점) ☐ 중간 정도 우울증 의심(10~19점) ☐ 심한 우울증 의심(20~27점)
우울증	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 증상없음(영역별 0~5점) ☐ 전문의 진단 필요(빈도 또는 고통 6점 이상)
조기정신증	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 특이소견 없음(0~5점) ☐ 인지기능 저하 의심(6점 이상)
인지기능장애	☐ 해당 ☒ 비해당	
골밀도검사	☐ 해당 ☒ 비해당	측정부위 T-점수 고관절 ☐ 요추 ☐ 기타 ☐
		☐ 정상 ☐ 골감소증 ☐ 골다공증
노인신체기능검사	☐ 해당 ☒ 비해당	☐ 정상 ☐ 신체기능저하
노인기능평가 (문진)	☐ 해당 ☒ 비해당	낙상 ☐ 정상 ☐ 낙상 고위험자
		일상생활 수행능력 ☐ 정상 ☐ 일상생활 도움 필요
		예방접종 ☐ 인플루엔자 접종 필요 ☐ 폐렴구균 접종 필요 ☐ 접종 필요 없음
		배뇨장애 ☐ 정상 ☐ 배뇨장애 의심

심뇌혈관질환 위험평가

*심뇌혈관질환은 뇌졸중, 심근경색을 포괄하는 질환을 뜻합니다.

성명 유지우

성별 남성

연령 57세

검진일자 2025-10-17

심뇌혈관질환 위험도

나의 심뇌혈관질환 발생 위험
((연령) (성별) 평균 대비)

0.74배

향후 10년 이내에 심뇌혈관질환이 발생할 확률

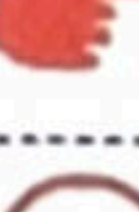
유지우님 5.4%
57세 남성 평균 7.2%

0 20 40 60 80 100

심뇌혈관 나이

52세

건강관련요인 알아보기

건강관련요인	현재상태	→	목표상태	건강신호등
 체중 허리둘레	68.1kg 84.0cm		65.0kg 90.0cm 미만	주의
 신체활동	주 4회		주 5회 이상	주의
 혈압	138/89		120/80 mmHg 미만	주의
 담배사용	금연중		금연 유지	주의
 음주	고위험 음주		절주 또는 금주	주의
 공복혈당	107		100 mg/dL 미만	주의
 총 콜레스테롤 LDL 콜레스테롤	비대상 비대상		200 mg/dL 미만 130 mg/dL 미만	

위 결과는 유지우 님의 문진표와 검사결과를 토대로 현재상태와 목표치를 제시한 것입니다. 건강 신호등에서 '주의' 또는 '위험'에 해당하는 요인에 대해서는 적극적인 개선 노력이 필요합니다. 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 약을 드시고 계신 경우에는 혈압, 공복혈당, 콜레스테롤이 목표치로 조절되고 있어도 '주의'로 표시되며, 현재와 같이 지속적으로 관리하시길 바랍니다.

※ 위 목표 상태는 일반적인 권고안에 따른 것으로, 개인의 건강 수준에 따라 달라질 수 있으므로 의사와 상담하십시오.

건강관련요인을 개선하면

향후 10년 이내에 심뇌혈관질환이 발생할 확률이 현재 상태 대비

19%감소 (5.4% → 4.4%)

심뇌혈관 나이

52세 → 50세

귀하의 건강검진 결과를 위와 같이 통보합니다.

2025.10.30

판정일 : 2025.10.22

검진 의사 : 면허(자격)/번호 : 29306

성명 : 나석주

재단법인한국의학연구소강남의원(요양기관번호 : 11366338)

직무스트레스(기본형) 및 정신건강 설문 결과

검 사 일 2025-10-17	검 진 센 터 강남센터	
이 름 유지우	생 년 월 일 681019-1*****	성 별 남
단 체 명 *****	부 서 명 *****	

① 직무스트레스요인점수표

항 목	개인점수	참고치(전국근로자)					점수의 의미
		성별	하위25%	하위50%	상위50%	상위25%	
물리적 환경	33.3	남성	33.3이하	33.4~44.4	44.5~66.6	66.7이상	점수가 높을수록 물리적환경이 상대적으로 나쁘다.
직무요구	37.5		41.6이하	41.7~50	50.1~58.3	58.4이상	점수가 높을수록 직무요구가 상대적으로 나쁘다.
직무자율	46.7		46.6이하	46.7~53.3	53.4~60	60.1이상	점수가 높을수록 직무자율성이 상대적으로 낮다.
관계갈등	41.7		0이하	0~33.3	33.4~50	50.1이상	점수가 높을수록 관계갈등이 상대적으로 높다.
직무불안정	44.4		44.4이하	44.5~50	50.1~61.1	61.2이상	점수가 높을수록 직업이 상대적으로 불안정하다.
조직체계	38.1		42.8이하	42.9~52.3	52.4~61.9	62이상	점수가 높을수록 조직체계의 불합리한 요소가 상대적으로 많다.
보상부적절	33.3		55.5이하	55.6~66.6	66.7~77.7	77.8이상	점수가 높을수록 보상체계가 상대적으로 부적절하다.
직장문화	33.3		33.3이하	33.4~41.6	41.7~50	50.1이상	점수가 높을수록 직장문화에 상대적으로 문제가 있다.
총점	38.5		45이하	45.1~50.7	50.8~56.5	56.6이상	점수가 높을수록 직무스트레스가 높다.

* 소견

[KOSS 기준]

직무스트레스 평가 결과, 유지우님의 전체적인 스트레스 수준은 국내 전체 근로자 표준에 비해 낮아 매우 바람직한 수준입니다. 세부 항목별 스트레스 수준을 국내 전체 근로자 표준과 비교하면, 대인관계와 관련된 [관계갈등] 항목에서 스트레스 수준이 다소 높아 관리가 필요합니다. 결론적으로, 다소 높은 수준으로 평가된 항목의 원인 파악 및 관리를 위해 직업환경의학 전문의 또는 직무스트레스 전문가와 상담하는 것을 권합니다. 향후 1년 이내 직무스트레스 재평가를 통해, 직무스트레스 수준의 변화를 확인할 것을 권고합니다.

* 결과에 따른 조치

각 영역별 위험군, 고위험군에 해당하는 경우 반드시 아래의 '용어의 의미'를 참고 하시어 스트레스 원인을 줄일 수 있도록 개선해야 합니다. 직무스트레스로 인한 건강장해를 미리 예방하기 위해서는 증상이나 징후가 나타나기 전에 직무스트레스의 요인을 줄여주거나, 직무스트레스에 대한 대처능력을 키워주는 개인별 혹은 집단별 노력이 필요합니다. (※ 결과 및 사후관리에 대한 더 자세한 상담이 필요한 경우 해당 전문의와 상의할 수 있습니다.)

* 각 항목별 용어의 의미

물리적환경 직무 스트레스에 영향을 줄수 있는 근로자가 처해있는 물리적 환경을 일컫는 것으로서, 작업장식의 위험성, 공기의 오염, 신체부담 등을 말한다.	직무요구 직무에 대한 부담 정도를 평가하는 것을 의미하며, 시간적 압박, 업무 증가, 업무 중 중단, 과도한 책임, 과도한 직무부담, 휴식시간 등이 직무요구에 속한다.
직무자율 직무에 대한 의사결정의 권한과 자신의 직무에 대한 자량 활용성을 평가하는 것을 의미하며, 기술적 자량, 업무에 숙기능성, 직무수행권한등이 직무자율에 속한다.	관계갈등 회사내에서 상사 및 동료 간의 도움 또는 지지부족이 스트레스의 요인이 되는지를 평가하는 것을 의미하며, 동료의 지지, 상사의 지지, 전반적인 지지 등이 관계갈등에 속한다.
직무불안정 자신의 직업 또는 직무에 대한 안정성을 평가하는 것으로 타 직장 구직 기회, 고용불안정성등이 직무불안정에 속한다.	조직체계 조직의 전략 및 운영체계, 조직의 자원, 조직내 갈등, 합리적 의사소통 등이 직무 스트레스의 요인으로 작용하는 지를 평가하는 것을 의미한다.
보상부적절 업무에 대하여 기대하고 있는 보상의 정도가 적절한 지를 평가하는 것으로 존중, 내적 동기, 기대 부적합등이 여기에 속한다.	직장문화 서양의 형식적 합리주의 직장문화와는 달리 한국적인 집단주의적 문화, 비합리적인 의사소통체계, 비공식적 직장문화 등이 직장문화가 스트레스 요인으로 작용하는 지를 평가하는 것이다.

② 정신건강 설문평가

※참고치

①우울증			②수면장애				③외상후스트레스장애		
0~20 정상	21~24 위험군	25~ 우울증 의심	0~7 정상	8~14 경미한 불면증	15~21 중등도 불면증	22~28 심한 불면증	0~17 정상	18~24 위험군	25~ 고위험군

①우울척도의 설문 점수는(0)입니다.

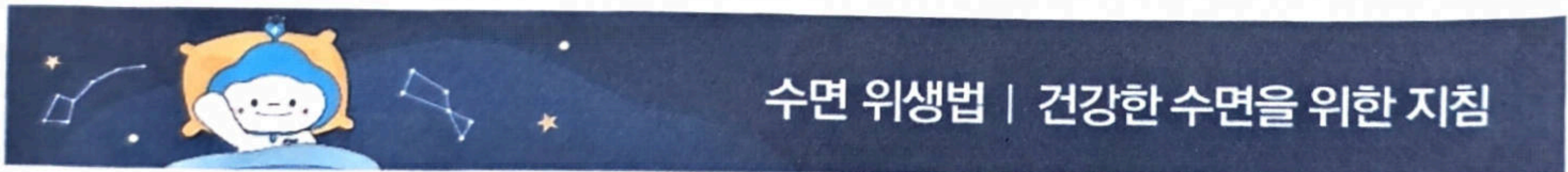
특이소견이 없습니다.

②수면장애의 설문 점수는(4)입니다.

특이소견이 없습니다.

③외상후스트레스장애(PTSD)의 설문 점수는(0)입니다.

특이소견이 없습니다.



수면 위생법 | 건강한 수면을 위한 지침



① 매일 규칙적인 시간에 잠자리에 들고 일정한 시간에 일어나십시오.



② 잠자는 환경이 조용하고 환하지 않도록 하십시오. 너무 덥거나 춥지 않도록 하십시오.



③ 매일 규칙적인 운동을 하십시오. 그러나 자기 직전에 지나치게 운동을 많이 하는 것은 오히려 잠을 방해할 수 있습니다.



④ 카페인이 들어 있는 음료나 음식을 피하십시오.



⑤ 자기 전에 흡연이나 음주를 피하십시오. 술은 처음에는 수면을 유도하는 것으로 생각되지만 후반기에 잠을 자주 깨게 하며 수면 무호흡증을 악화시킬 수 있습니다.



⑥ 배가 고픈 상태나 과식은 피하십시오.



⑦ 잠이 오지 않거나 중간에 깨어 잠이 오지 않을 경우에는 차라리 잠자리에서 일어나서 다른 일을 해보십시오. 다른 일을 하던 중에 잠이 오면 그 때 잠자리에 가도록 하십시오.



⑧ 밤에 밝은 빛에 노출되지 않도록 하십시오.



건강한 뇌 만들기, 작은 것부터 시작하세요!

CogMate™

결과리포트

실시일 2025년 10월 17일

ID 2506902887

성명 유지우

연령 56 (세)

성별 남성

이 결과리포트는 브레인퍼포먼스(뇌 건강도) 저하 가능성을 판별하는 것입니다.
[CogMate]는 브레인퍼포먼스 저하 가능성에 관련한 집중력 점수와 기억력 점수를 나타냅니다.
개인의 브레인퍼포먼스를 나타내는 지표는 0~50의 수치로 표시됩니다.

***반드시 읽어주세요(필독)**

이 결과리포트로 제공되는 정보는 질병의 예방이나 조기 발견에 대한 관심을 위한 것으로, 의사의 조언이나 현재 받고있는 치료를 대신할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 이 리포트로 제공되는 정보나 결과는 질병의 예방이나 진단을 위한 것이 아닌 점 양해 바랍니다.

브레인퍼포먼스인덱스 (BPI: Brain Performance Index)

BPI는 집중력, 기억력, 시각학습, 주의력, 반응 속도를 종합 평가하는 '뇌 건강 지수'입니다.

A : 정상입니다.

20.0 ~ 50.0

B : 경계선입니다.

15.0 ~ 19.9

C : 유지 및 증진 활동 필요

0.0 ~ 14.9

집중력 점수

22 (점) [A] 집중력 점수란 브레인퍼포먼스 관련 반응 속도나 주의력을 종합적으로 평가한 점수입니다.

기억력 점수

34.2 (점) [A] 기억력 점수란 브레인퍼포먼스 관련 시각 학습이나 기억력을 종합적으로 평가한 점수입니다.

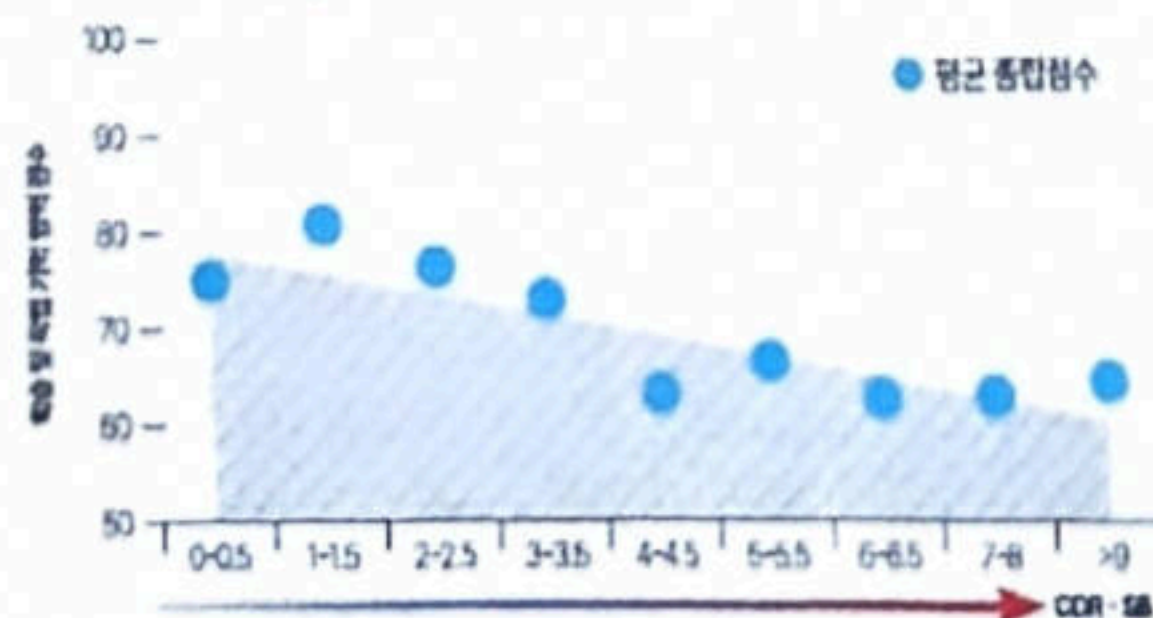
뇌 나이

47 (세) *CogMate의 테스트 결과는 검사자의 나이를 기반으로 합니다.
해당 결과는 건강의 지표로 유용하게 사용될 수 있습니다.

CBB 종합점수는 경도인지장애 및 치매 진단 검사와
유의미한 관계를 나타냅니다.

CBB 종합점수는 치매선별검사(CDR-SB) 점수와 통계적으로 유의한 상관관계가 있음이 관찰되었습니다!

경도인지장애 및 알츠하이머 치매 환자에서
CBB 종합점수와 치매선별검사(CDR-SB) 점수의 상관관계



한국에자이주식회사

전화: 02-3451-5550(1번)

브레인퍼포먼스 유지 및 향상방법

생활습관 개선



규칙적인 운동

뇌의 활성화를 위해 주 2회 30분 이상의 유산소 운동을 추천합니다.



건강한 식습관

야채, 과일, 생선 섭취 부족은 인지기능 저하의 위험을 초래합니다. 균형잡힌 식사를 추천합니다.



금연

흡연자는 비흡연자에 비해 1.5~2배 정도 인지기능 저하의 위험이 높습니다. 금연을 추천합니다.



과음자제

과도한 음주는 인지기능 저하에도 영향을 줄 수 있습니다. 과음은 피하세요.

심신 관리



체중 관리

비만은 인지기능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 식단과 운동으로 체중을 조절해주세요.



혈압 관리

중년 고혈압은 인지기능 저하의 원인입니다. 예방을 위해서는 염분 섭취를 줄여주세요.



혈당 관리

혈당 관리가 되지 않으면 인지기능이 저하됩니다. 공복 시 혈당 100mg/dl 이상이면 당뇨병 발생의 위험이 2배 이상 높아집니다.



콜레스테롤 관리

콜레스테롤의 증가는 인지기능 저하의 원인이 됩니다. 식이섬유가 많은 식품을 섭취하세요.



마음 건강

우울증은 인지기능을 2배 이상 저하시킵니다. 질 높은 수면을 유지해주세요.



청력 유지

청력 기능이 떨어지면 인지기능이 저하될 위험이 있습니다. 대화를 늘려주세요.

그 외



지적 활동

생각하고, 기억하고, 판단하는 등 일상 생활의 적극적인 지적 활동을 통해 인지기능 저하를 예방할 수 있습니다. 인지기능 저하 예방에 도움이 됩니다.



사회 활동

외로움은 인지기능을 저하시킬 수 있습니다. 적극적인 사회 활동을 통해 인지기능을 활성화해주세요.

감수: 도쿄부건강장수의료센터 뇌신경내과 부장 이와타 아츠시(준)

자세한 사항은 홈페이지를 참고해주세요.

*치매질환진료가이드라인 2017, 치매질환진료가이드라인 작성위원회, p131

● 정기적인 검사를 추천합니다.

정기적으로 검사를 실시하여 검사자의 브레인퍼포먼스 추이를 확인할 수 있습니다.

이전과 비교 시 브레인퍼포먼스 저하의 가능성이 있다고 판정되신 분은 3개월 내에 재검사를 추천드립니다.

● 여러가지 원인이 있습니다.

브레인 퍼포먼스 저하의 원인은 수많은 이유가 있습니다.

브레인퍼포먼스의 저하를 불러오는 위험한 요인: 스트레스, 불안감, 주의결함장애, 우울증, 갑상선 질환이나 당뇨병 등의 성인병, 음주나 화학 조미료 의존, 비타민 B12 부족, 뇌혈관 질환, 의약품, 두부외상 등.

이 결과리포트로 제공되는 정보는 질병의 예방이나 조기 발견에 대한 관심을 위한 것으로, 의사의 조언이나 현재 받고 있는 치료를 대신 할 수 있는 것은 아닙니다. 또한 이 리포트로 제공되는 정보나 결과는 질병의 예방이나 진단을 위한 것이 아닌 점 양해 바랍니다.

miri

건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI) 검사일시 | 2025.10.17

성명 | 유지우 나이 | 56세 성별 | 남성

종합 평가

보통

유지우님의 점수: 70점

미흡

보통

우수

최우수

동일 연령 평균 점수 72점

대한민국 성인 남성 100명 중 45등

동일 연령대(55~59세 남성) 100명 중 42등

유지우님의 종합 건강 성적은 **보통**입니다. 동일 연령대 대비 낮은 점수를 가지고 계시네요.

종합평가 및 건강 나이는 검진 결과, 생활습관(흡연, 음주, 신체활동), 그리고 기저 질환 여부를 종합하여 산출됩니다. 각 등급은 건강 점수와 동일 연령대비 상대적인 건강 수준을 함께 고려하여 분류됩니다.

건강 나이

56세

55세

기대수명 83.8세

실제 나이 건강 나이

이번 건강검진 결과를 고려했을 때, 유지우님의 건강 나이는 55세로, 실제 나이보다 1년 젊고, 기대 수명은 83.8세입니다.

※56세 대한민국 남성의 평균 기대 수명은 82.9세입니다.

신체건강과 생활습관 성적

신체건강 성적 신체건강 성적은 검진 결과로 계산됩니다.

항목	심장	폐장	신장	간	혈관	폐	비만
등급	미흡	보통	최우수	우수	보통	-	보통
점수	42점	47점	78점	68점	56점	-점	56점
등수 (동일 연령대 기준)	84/100	66/100	6/100	40/100	61/100	-/100	22/100

생활습관 성적 생활습관 성적은 설문 응답 내용으로 계산됩니다.

항목	흡연	음주	신체활동
등급	보통	보통	최우수
점수	57점	55점	100점
등수 (동일 연령대 기준)	28/100	54/100	1/100

기저 질환 설문 응답 내용으로 표기됩니다. ● 해당 ● 미해당

고혈압	이상지질혈증	당뇨	심혈관질환
뇌혈관질환	간경화	치매	암질환

건강성적표 어떻게 해석할까요?
해석 방법 확인과 추가 문의는 좌측의 QR 코드를 스캔해 주세요.
위 서비스는 한국인을 대상으로 비교한 결과를 보여주고 있습니다.

한국의학연구소 건강검진 결과



건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 유지우

나이 | 56세

성별 | 남성

신체건강 성적 세부 항목

신체건강 성적 산출에 활용되는 세부 검진 결과를 확인할 수 있습니다. 검진 결과가 정상범위 내에 있는지, 동일 연령대 대비 건강 수준이 어떠한지 비교해 보세요. 이 결과는 참고용이며, 질병 진단이나 개별 수치 의미는 전문의 상담을 권장합니다.

동일 연령대 대비 00(검사결과 - 동일 연령대 평균) □ 위험범위 ■ 정상범위 ▼ 현재 나의 위치 ▲ 동일 연령대 평균

심장 42점 미흡

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
수축기 혈압	138 (▲15) (mmHg)	80 100 120 140 160
이완기 혈압	89 (▲9) (mmHg)	50 65 80 95 110
최고-최저 혈압	49 (▲6) (mmHg)	25 35 45 55 65

혈당 47점 보통

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
공복혈당	107 (▲2) (mg/dL)	60 80 100 120 140 160
당화혈색소	- (-) (%)	4 5 6 7 8

신장 78점 최우수

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
크레아티닌	0.8 (▲0.2) (mg/dL)	0 0.5 1 1.5 2
BUN	13 (▲3) (mg/dL)	0 6 12 18 24 30
요단백	음성 (0)	음성 약양성 +1 +2 +3 +4
사구체 여과율 (GFR)	99 (▲10) (ml/min)	40 60 80 100 120 140

간 68점 우수

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
AST	25 (▲2) (IU/L)	0 20 40 60 80 100
ALT	18 (▲8) (IU/L)	0 20 40 60 80 100
GTP	25 (▲38) (IU/L)	0 20 40 60 80 100

혈관 56점 보통

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
총 콜레스테롤	193 (▲3) (mg/dL)	100 150 200 250 300
LDL	127 (▲18) (mg/dL)	10 50 90 130 170
HDL	56 (▲8) (mg/dL)	10 30 50 70 90
*HDL/LDL ratio	0.44 (0)	

수치가 낮을수록 심혈관질환의 위험이 상대적으로 낮다고 알려져 있습니다.

Barter P. et al., N Engl J Med (2007)

폐 미시행

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
FVC(%)	- (-) (%)	60 70 80 90 100
FVC(L)	- (L)	남성 평균 수치는 4.2L 입니다. *해당 수치와 키, 연령, 체중을 고려하여 %값이 산출됩니다*
FEV1(%)	- (-) (%)	60 70 80 90 100
FEV1(L)	- (L)	남성 평균 수치는 3.2L 입니다. *해당 수치와 키, 연령을 고려하여 %값이 산출됩니다*
FEV1/FVC	- (-) (%)	50 60 70 80 90 100

비만 56점 보통

항목	수치 (동일 연령 평균 대비)	나의 위치
BMI	23.8 (▲0.7) (kg/m ²)	15 20 25 30 35
허리둘레	84 (▲3) (cm)	60 75 90 105 120
중성지방	52 (▲114) (mg/dL)	50 100 150 200 250

한국의학연구소 건강검진 결과

miri 건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 유지우

나이 | 56세

성별 | 남성

| 만성질환 10년 내 발병 확률

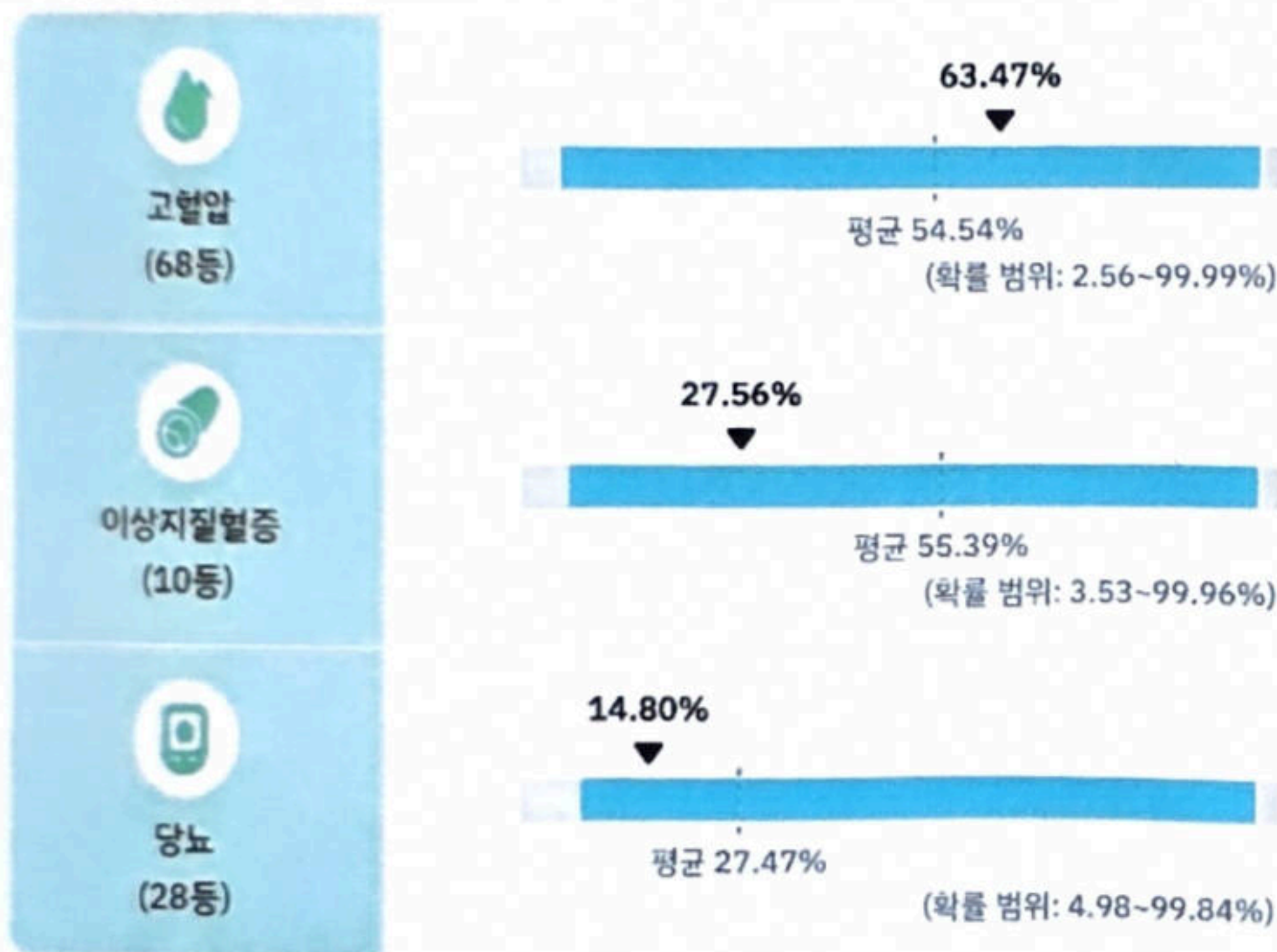
연령, 성별, 기저질환, 복용 약물, 검진 자료, 생활습관을 종합적으로 고려하여 예측한 10년 내 만성질환 발병 확률을 확인할 수 있습니다. 등수는 동일 연령대 100명을 기준으로 표기되며, 위험 요인은 연령, 성별을 제외한 주요 요인으로 표기됩니다. 동일 연령대 평균과 나의 확률을 비교하고, 질환 발병 확률을 높이는 요인을 확인해보세요. 단, 해당 수치는 통계적 예측값으로 진단이나 치료 목적으로는 사용할 수 없습니다.

▼ 나의 확률 ■ 동일 연령대 확률 범위 | 동일 연령대 평균 확률 ■ 정상 범위 초과 ■ 동일 연령대 대비 관리 필요 ■ 해당 없음

*기타는 확률 산출에 활용된 주요 4개 요인 외 모든 요인을 포함하며, 하나라도 해당하면 해당 요인이 하단에 표기됩니다.

*질환명(측정 지표/약)은 이번 검진에서 측정 지표값이 해당 질환 의심 범위에 해당하거나, 해당 질환 치료를 위해 약물 복용 중이라고 응답한 경우 표기됩니다.

대사성 질환



위험 요인

고혈압 가족력 ■ 높은 수축기 혈압
 높은 이완기 혈압 ■ 높은 BMI ■ *기타
 * 과거 흡연, 음주

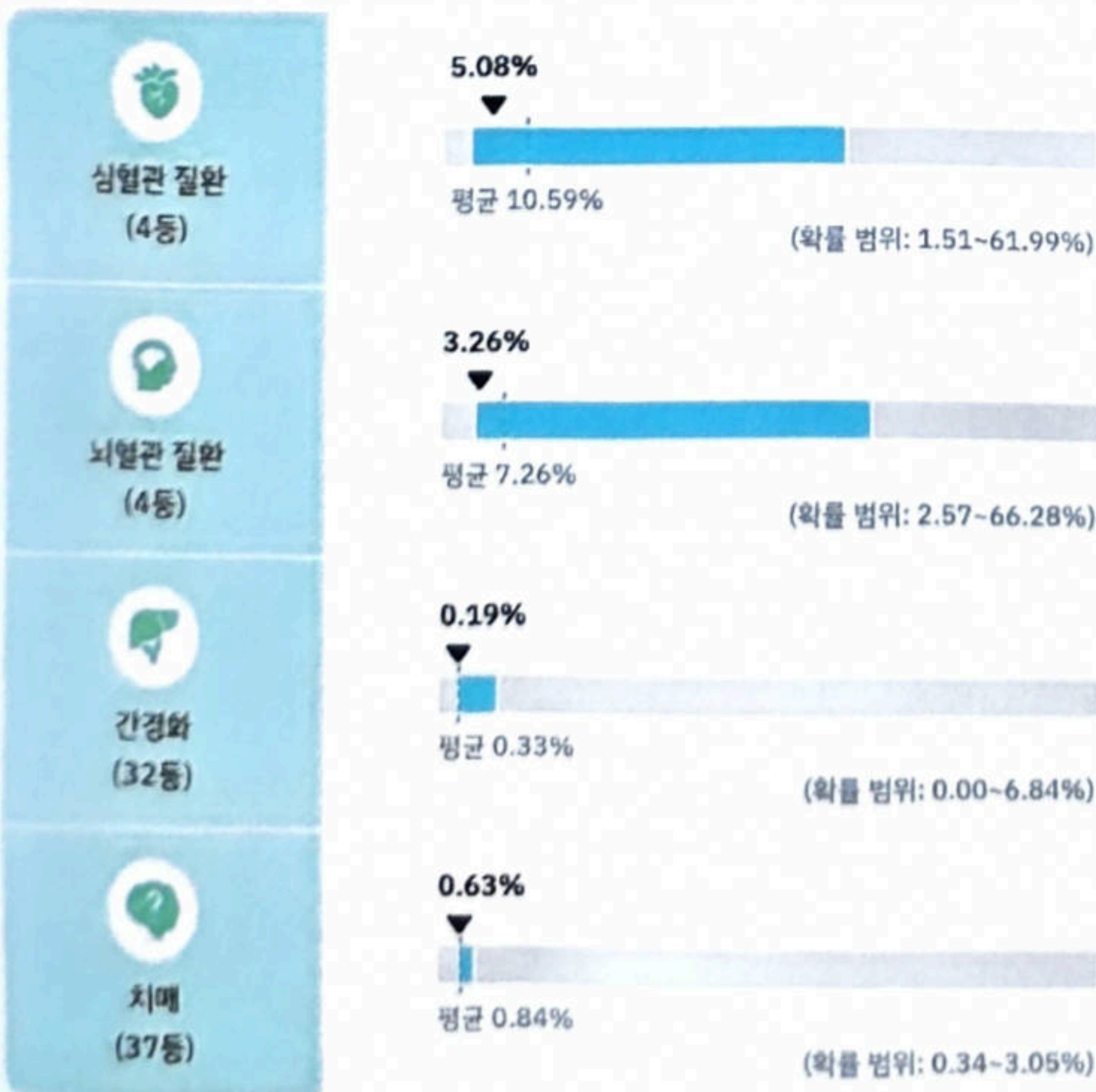
위험 요인

높은 LDL/HDL 비율 ■ 당뇨(측정 혈당/약)
 높은 중성지방 ■ 현재 흡연 ■ *기타
 * 과거 흡연, 전당뇨 수준 혈당, 높은 콜레스테롤

위험 요인

당뇨 가족력 ■ 높은 공복혈당
 높은 BMI ■ 현재 흡연 ■ *기타
 * 음주, 높은 혈압, 과거 흡연

주요 질환



위험 요인

당뇨(측정 혈당/약) ■ 심혈관질환 가족력
 고혈압(약) ■ 현재 흡연 ■ *기타
 * 높은 혈압, 전당뇨 수준 혈당, 과거 흡연 등

위험 요인

당뇨(측정 혈당/약) ■ 신장기능저하(GFR<60)
 현재 흡연 ■ 높은 혈압 ■ *기타
 * 전당뇨 수준 혈당

위험 요인

높은 AST ■ 고위험 음주
 바이러스성 간염 ■ 현재 흡연 ■ *기타
 * 과거 흡연

위험 요인

당뇨(측정 혈당/약) ■ 높은 혈압
 심혈관 질환 ■ 현재 흡연 ■ *기타

한국의학연구소 건강검진 결과

miri 건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 유지우

나이 | 56세

성별 | 남성

주요 암 6종 10년 내 발병 확률

만성질환 발병 확률과 동일한 방법으로, 주요 암 6종의 10년 내 발병 확률을 확인할 수 있습니다. 차트를 통해, 발병 확률이 높은 암종과 위험요인을 확인해 보세요. 단, 발병 확률은 통계적 예측값으로 진단이나 치료 목적으로는 사용할 수 없습니다.

암질환

나의 확률 | 동일 연령대 평균 확률
동일 연령대 평균 대비 ● 높음 ● 낮음 ※ 유질환자는 확률 및 등수가 표기되지 않습니다.



※ 암 가족력은 전체 암 종류 중 하나라도 가족력이 있다고 응답하신 경우 표시됩니다.

동일 연령대 대비 등수가 가장 안 좋은 암은 위암입니다.

유지우님의 동일 연령대 대비 등수가 가장 안 좋은 암은 위암(21등)입니다. 누적 흡연량, 기타요인이 해당 질환의 발병 확률을 높이고 있어 이에 대한 적극적인 관리가 필요합니다.

위험요인

위암

만성 위축성 위염

암 가족력

저체중

누적 흡연량

*기타

* 전당뇨 수준 열당

대장암

만성 염증성 대장질환

저체중

높은 공복혈당

높은 GTP

*기타

* 누적 흡연량

간암

당뇨(속정 열당/약)

고위험 음주

간경화

높은 AST

*기타

* 전당뇨 수준 열당

췌장암

저체중

당뇨(약)

높은 공복혈당

높은 GTP

*기타

* 흡연 기간

폐암

만성 폐쇄성 폐질환

당뇨(속정 열당/약)

현재 흡연

저체중

*기타

* 누적 흡연량

전립선암

암 가족력

당뇨(속정 열당/약)

신장기능저하(GFR<60)

복부비만(허리둘레)

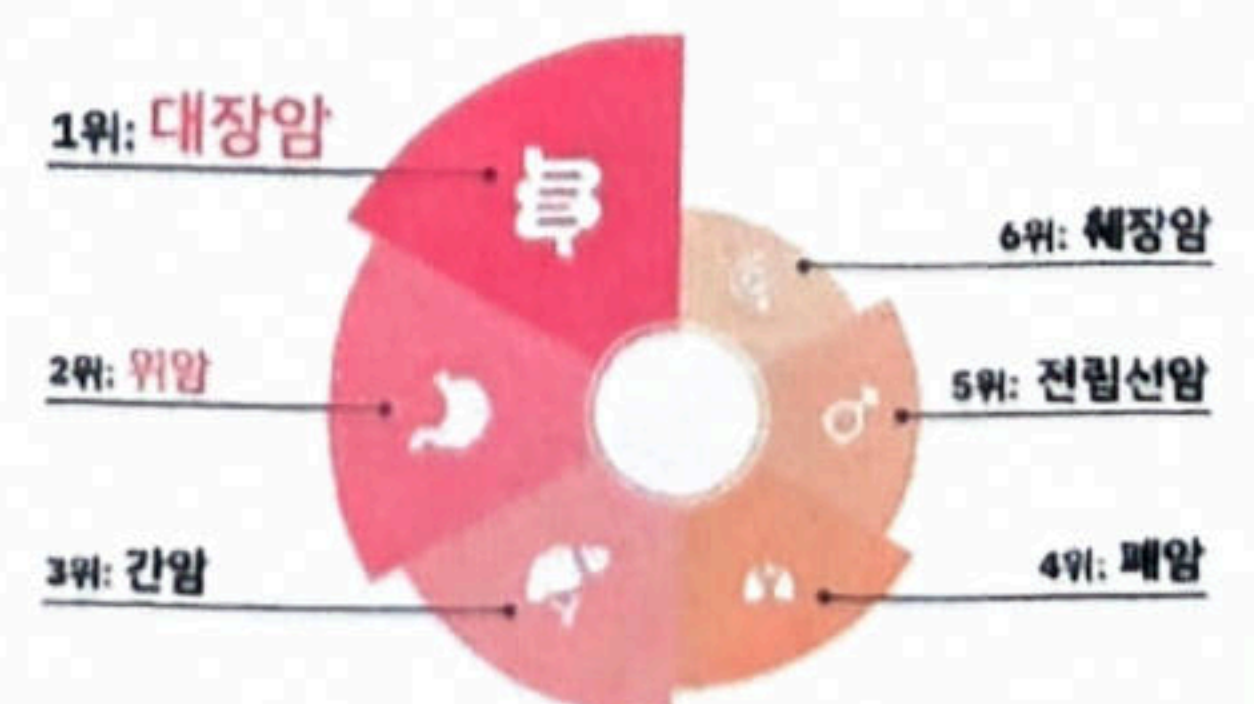
*기타

동일 연령대에서 가장 많이 발생하는 암은 대장암입니다.

위에서는 위험요인을 고려한 발병 확률(통계적 예측값)을 알아봤다면, 우측 그래프를 통해 실제로 동일 연령대에서 많이 발생하는 암종 순서를 확인할 수 있습니다.

유지우님의 경우, 대장암에 대한 발병 확률이 동일 연령대 평균보다는 낮지만 동일 연령대에서 발병 빈도가 높은 임이므로 특히 더 관심을 갖고 관리해주세요.

※ 55~59세 남성에게 많이 발생하는 암은?



한국의학연구소 건강검진 결과

miri 건강 성적표

검사기관 | 한국의학연구소(KMI)

검사일시 | 2025.10.17

성명 | 유지우

나이 | 56세

성별 | 남성

위험 요인 잡고 건강 지키기

아래 버블들은 건강에 영향을 미치는 위험 요인을 나타냅니다. 크기는 해당 요인의 영향력을, 색상은 관리 필요도를 의미합니다. 위험도가 큰 요인을 관리하여 건강 성적을 향상시킬 수 있는 방안을 함께 알려드립니다. 위험 요인 관리를 실천하고, 정기적인 검진을 통해 위험 요인이 개선되는지 확인해 보세요.



유지우님에게 우선순위가 높은 주요 위험 요인은 **혈당이상, 혈압이상, 비만**입니다. 해당 요인들을 관리할 수 있는 맞춤 건강관리 팁을 확인해보세요.

건강한 변화를 위한 건강관리의 첫걸음!

건강관리의 완성! 조금만 더 힘내요!

STEP 1 건강에 해로운 습관 하지 않기

흡연
금연 유지, 간접 흡연 조심하기

음주
건강을 위해 소량의 음주도 피하기

내 건강에는 이런 이유로 더 위험해요 :

- 혈압 상승, 심뇌혈관 질환 위험 증가
- 간 손상, 혈압 상승, 중성지방 증가

STEP 2 운동으로 위험요인 개선하기

유산소 운동
중강도 기준*주당 150분 이상 시행 (150분을 최소 5일 이상 나누어 진행)

근력 운동
주당 2일 이상 시행 (모든 부위 포함, 휴식일을 두고 시행)

내 건강에는 이런 효과로 더 좋아요 :
혈압 조절, 지질 수치 개선

운동시 이런 점은 주의가 필요해요 :
급격한 혈압 상승 피하기
※ 고강도 운동은 피하기
※ 운동 전/후 충분한 준비운동은 필수

*중강도 운동 : 약간 숨이 차지만, 대화 가능한 정도

STEP 3 좋은 식습관으로 건강 완성하기

피해야 할 식사
고염식(소금은 하루 6g 이하로 제한), 포화 지방이나 콜레스테롤 과다섭취

도움이 되는 식사
칼륨, 칼슘, 마그네슘, 식이섬유, 불포화지방 산이 풍부한 음식

이런 영양성분을 섭취해 보세요 :

칼륨 : 나트륨 배출 및 혈압 조절 효과
• 바나나, 시금치, 토마토, 감자 등

칼슘 : 혈압 강하 효과
• 우유, 유제품, 뼈째 먹는 생선, 미역 등

불포화지방산 : 좋은 콜레스테롤(HDL) 증가 및 나쁜 콜레스테롤(LDL) 감소
• 들기름, 올리브오일, 견과류 등